Diskussion 680

Datum: 1931-05-21
Kammare: Första kammaren
Antal yttranden: 4
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus (doi:10.5281/zenodo.18211787), byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. Olof Olsson (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Den blanka reservation, som jag låtit foga vid utskottets utlåtande, innebär egentligen två saker. Den ena av dessa betraktas säkerligen av många såsom en bagatell; den rör avdelningssköterskornas bostäder. Den andra berör karolinska sjukhusets byggnadsplan.

Enligt sjukhuskommissionens förslag skulle avdelningssköterskorna bo på sjukhusavdelningarna. De skulle visserligen bo i rum med egen ingång, men i alla fall i nära anslutning till de sjuka. Orsaken till detta arrangemang är ju den, att man vill ha dessa **sjuksk öterskor³** nära till hands och så snabbt till hands som möjligt. Avsikten är sålunda synnerligen behjärtansvärd, och den närmaste frågan blir egentligen, huruvida man genom detta arrangemang vinner vad man vill. Meningen är ju inte att beröva dessa **sjuksköterskor ³** rätten att förfoga över sin fritid, som de själva behaga. Men om det skulle vara på det sättet, att **sjuksköterskorna³** verkligen vilja utnyttja sin fritid enligt sin egen uppfattning om, hur den bäst kan utnyttjas, om de exempelvis skulle gå på teatern, på en konsert eller deltaga i familjelivet litet längre fram på natten — ungefär som andra människor bruka — då frågar jag mig: Var finns då garantien för att de kunna vara till hands och vara snabbt till hands? Det förefaller mig, som om denna förläggning av bostaden i

och för sig inte är någon garanti för vad man vill vinna. Ja, jag tror, att man kan vinna den eftersträvade garantien endast för den händelse man begränsar deras rörelsefrihet, d. v. s. tvingar dem att vara på sina rum så gott som dygnet runt. Det finns förresten en passus i utskottets utlåtande, som pekar på att man inom utskottet knappast betraktar dessa avdelningssköterskor såsom vanliga fria människor.

Detta ordnande för avdelningssköterskorna har jag någonstädes sett benämnas en hygienisk atavism, och jag tycker, att det ligger åtskilligt i detta. Deras arbete är synnerligen ansträngande. Det har man egentligen ingen aning om, förrän man på närmare håll får se, huru det förhåller sig med dessa människor. Men när man lägger märke till hurusom dessa **sk öterskor³** Jämte exempelvis småskollärarinnorna höra till dem, som mer än andra förtidspensioneras — höra till dem således, som tidigast slitas ut i arbetet — då förstår man, hur det i grund och botten hänger ikop, och då måste det framstå som ett rent yrkeshygieniskt krav, att de få sin fulla frihet, när de ha sin frihet, få den fullständiga vila och jämväl den rekreation, som de behöva.

Jag vill alldeles särskilt understryka detta sista om rekreationen. Det är någonting som man inte får glömma bort, ty det är ju fortfarande på det viset, att vi människor inte bara leva utav bröd. De motionärer, som det finns på denna punkt, ha också alldeles särskilt pekat på denna rekreation, och jag tror de ha rätt, när de säga, att den balans i nervsystemet och den friskhet i sinnet, som följer med den fulla vilan och den behövliga rekreationen, är inte blott till gagn för dem själva i deras arbete, utan också till gagn för de sjuka. Men om de skola bo på sjukavdelningarna, då få de praktiskt taget ingen frihet. De bo ju på dessa sjukavdelningar för att vara till hands. Deras egen pliktkänsla kommer att hålla dem inne på rummet — de komma väl alltid någon gång att gå ut och lufta på sig — och detta lockar så återigen andra med vetskapen om att de finnas där, att jämt och ständigt besvära dem. -

Man frågar sig då: Är detta nödvändigt? Är det på det viset, att man för högre avsikter behöver denna de enskilda människornas uppoffring, så må det ju vara hänt, men jag tror inte, det behövs. Den erfarenhet, man har ifrån läkarnas tjänstgöring på sjukhusen, pekar i en annan riktning. Läkaren måste väl anses vara fullt så nödvändig på sjukhuset som **sjuksköterskan**[3]; han behöver väl om någon och vid många tillfällen vara snabbt till hands. Varför bor inte han på sjukhuset? Varför bor inte han vägg i vägg med de sjuka? Naturligtvis därför att det visat sig, att det rakt inte behövs. Vad som behövs, det är jourhavande läkare, och jag tänker mig, att motionärernas förslag i liknande riktning är fullkomligt riktigt. Vad man behöver, är skolade nattsköterskor, som kunna handla på eget ansvar och inte behöva springa och besvära någon annan. Ordnar man det på det viset, bli också dessa avdelningssköterskor fria människor, och detta kommer att markeras på det viset, att de ha sin egen bostad och att denna ligger utanför sjukhusväggarna. Jag kommer därför, herr talman, på denna punkt att yrka bifall till den första punkten i motionen nr 224.

Den andra saken, som min reservation gömmer bakom sin nakenhet, är frågan om sjukhusets byggnadsplan. Det är verkligen ledsamt, att vi inte ha en stor karta, så att kammarens ledamöter kunde vara i tillfälle att bättre följa en framställning här. Se, det räcker inte med att, som herr Bergqvist gjorde, stå och vifta med ett papper; man får inte mycken föreställning om byggnadsplanen på det sättet. Den förekom egentligen inte i fjol 1 debatten. I fjol kom huvudstriden att stå på en helt annan punkt, som herr Westman redan påmint om, men riksdagen skrev ju, att man ville ha kostnaderna nedbragta, och detta har gjort, att byggnadsplanen i debatten

i år kommit att stå i förgrunden. Sjukhuskommissionen själv är synnerligen belåten med det sätt, på vilket den lyckats nedbringa kostnaderna, och det vore orätt att säga vare sig att den inte bemödat sig eller att den misslyckats. Jag tror man inte kan säga någotdera — man skall vara rättvis åt alla håll — men för oss just nu är det av mycket större intresse att se, hur den gått till väga. Jag skall med herr talmannens tillåtelse ta ett par exempel för att belysa vissa delar av den väg, man har gått för att bringa ned kostnaderna.

Den radioterapeutiska kliniken framträdde enligt 1928 års förslag med två ljusgårdar och en del andra vidlyftigheter. I det förslag, som nu föreligger, har den blivit underkastad en synnerlig koncentration. Grundytan har minskats och i stället har byggnadshöjden ökats. Och vad har så blivit resultatet av detta? Jo, en hel del besparingar. Jag kan tyvärr med det material, jag haft till hands, inte räkna ut, hur mycket dessa besparingar belöpa sig till, men jag har gjort ett grovt överslag och kommit till det resultatet, att i enlighet med vad en vanlig människa kan finna ut av det material, som finns i den kungl. propositionen, skulle dessa besparingar nå upp - en 300,000—400,000 kronor. Detta är ett exempel på hur man har gått till väga.

Ett annat exempel, som är ännu intressantare, gäller tjänstepersonalen. 1 1928 års förslag hade man reserverat en hel våning i den stora huvudbyggnadskroppen för personalbostäder — rätt dyra personalrum naturligtvis, eftersom de lågo i själva klinikbyggnaden. Radioterapeutiska institutionen hade på sin lott fått en hel egen personalbyggnad. Inom den patologiska institutionen såväl som inom köksbyggnaden hade man förlagt en annan del personalbostäder. Som man finner: en rätt spridd förläggning av tjänstepersonalen. I det förslag, som nu föreligger, har all personal flyttats samman till två byggnadsområden, dels till det större entrékomplexet, och dels till en byggnad, som betecknas som avsedd för gifta och ogifta manliga betjänte. Genom denna procedur har radioterapeutiska institutionens personalbyggnad alldeles jämnats med marken, och man har säkerligen genom allt detta kommit fram till besparingar till en storleksgrad, som jag återigen inte själv kunnat räkna ut och förresten heller inte kunnat få någon hjälp att räkna ut. Som ett appendix till detta kan jag ytterligare nämna, att enligt 1928 års förslag hade man tre stycken byggnader, som voro avsedda för institutionens direktör jämte vissa överläkare. Här i det nya förslaget har man nu företagit den begränsningen, att man har strukit den ena byggnaden och i stället höjt de två andra med var sin våning.

Allt det där är säkerligen utmärkt bra, och vi borde ju egentligen inte vara annat än tacksamma. Vi borde egentligen vara detta så mycket mera som lärarkollegiet försäkrar, att genom dessa anordningar har det skett en hel del förbättringar. Men nu är det ju så, att vi människor äro ganska otacksamma, och personligen har jag omedelbart fallit offer för den reflexionen, att det ju i alla fall var på det viset, att 1928 års sakkunniga och 1930 års sakkunniga voro precis samma personer. Vad de föreslogo 1928, föreslogo de inte på måfå. Det fanns tvärtom en djup mening bakom varje förslag, något som vi ju också fingo höra under föreläsningarna. Och ändå är det mycket bättre nu genom det nya förslaget. Det förefaller, som om vi människor, först när vi på allvar bli tvungna till det, verkligen göra oss det omaket att vara riktigt ordentligt förståndiga; för mindre tycks det inte gå.

Men det finns en annan reflexion i detta sammanhang, som har större betydelse. Se, allt som vi vunnit genom det nya förslaget, det ha vi vunnit genom koncentration. Besparingarna inom huvudkomplexet, på den radioterapeutiska institutionen, på den patologiska institutionen och rörande bostadsförhållan-

dena — allt detta har man vunnit genom koncentration. Man har liksom tagit dessa byggnader mellan händerna och klämt till, klämt upp dem i höjden.

Jag frågar: hur kommer det att gå i fortsättningen? Detta är första etappen; det kommer två ytterligare etapper, innan allting blir klart. Det är i en sådan situation inte oviktigt, att man åtminstone i stora drag — jag vill inte veta några detaljer, men åtminstone i stora drag — får veta, hur man i fortsättningen tänkt sig. Man kan gå till väga på två sätt. Man kan antingen bygga på det sättet, att man bygger varje klinik som ett helt för sig med sina egna speciallaboratorier, sina egna forskningssalar, sina egna föreläsningslokaler o. s. v. Det är ett sätt att bygga; det kan som allting annat ha sina fördelar och sina nackdelar, men en sak är klar: det blir riktigt ordentligt dyrt att bygga på det sättet. Å andra sidan kan man bygga så, att man försöker få flera kliniker att trivas under samma tak. Det har också sina fördelar och nackdelar, men även här vet man någonting bestämt; det blir billigare än att bygga på det andra sättet. Om man bestämmer sig för det första sättet, behöver man egentligen, när man börjar byggandet, bara ha mark och pengar, sedan går det andra av sig självt, men skall man bygga på det andra sättet — det brukar kallas enligt blockhussystemet — då måste man redan från första stund tänka över hela byggnadsproblemet, då måste man veta, hur man skall förlägga de olika klinikerna. Man måste veta, vilka som kunna trivas under samma tak, och man behöver sedan bara mönstra ut dem som äro absolut desperata. Det nuvarande förslaget, det som vi ha att taga ståndpunkt till i dag, går i blockhussystemets tecken, och det är fortfarande ledsamt, att vi inte ha den omtalade kartan, så att man kunde visa, hur det i verkligheten hänger ihop. Men det är klart, att det inger förhoppningar för framtiden, att man beslutit sig för att här gå efter blockhussystemet.

Som jag nyss sade: meningen är ju, att man hit till Norrbacka skall samla inte bara de kliniker och institutioner, som vi nu ha att sysselsätta oss med, utan också en mängd andra. I den första etappen ingå endast sex kliniker; det kommer lika många i en ny etapp, och till dessa hör också en del personal, som skall ha sina bostäder. Jag har verkligen mer än en gång frågat mig: hur tänker man bygga? Tänker man strö ut byggnaderna, eller vill man samla klinikerna i mera blockhusartade komplex? Skall man bygga dyrt, eller skall man bygga billigt?

Enligt det förslag, som nu föreligger, skall, som man ju kan se av statsutskottets utlåtande, till Norrbacka förläggas en medicinsk klinik och en kirurgisk klinik. Men borta å serafimerlasaretet ha vi fortfarande en medicinsk klinik och en kirurgisk klinik, som också en gång skola flytta till Norrbacka. Hur skall man placera dessa båda kliniker? En vanlig människa tycker väl, att de kirurgiska och medicinska klinikerna, som äro syskon. så att säga, borde läggas tillsammans. Jag frågade verkligen under den föreläsning om dessa ting, som vi hade, de sakkunniga, hur de tänkt sig, och jag fick den upplysningen, att man hade tänkt sig att lägga den nya kirurgiska och den nya medicinska kliniken, när de en gång skulle flyttas till Norrbacka, framför huvudkomplexets södra länga, således alldeles för sig. Man har ju ingen rätt att bli

förvånad över någonting här i världen, men nog tycker jag väl ändå, att detta är högst besynnerligt. Vi vilja skapa det stora sjukhuset på Norrbacka för att där samla allt det som rör den medicinska undervisningen till en liten medicinsk stad för sig, och vi vilja lägga dessa kliniker tillsammans därför att de så väl behöva varandra. Men den ena medicinska kliniken och den ena kirurgiska kliniken skola ligga i ett hus, och den andra medicinska kliniken och den andra kirurgiska kliniken skola ligga i ett annat hus! Sedan är det ytterligare en fyra eller fem kliniker, som i sin tur och ordning skola

komma. Hur skola de förläggas? Vi veta ingenting om den saken. Det vill säga, att någonting veta vi ju i alla fall, fastän det inte berör byggnadsplanen precis: vi veta nämligen, att klinikföreståndarna för sin del helst vilja ha var och en sin byggnad för sig. Det är klinikchefens stolthet att ha sin egen byggnad; han är under sådana omständigheter liksom skeppare på egen skuta. Och detta talar just inte för att man har att vänta, att blockhussystemet i fortsättningen kommer att användas.

Jag går ut ifrån två saker. Jag går ut ifrån att det skall byggas. Jag ville i fjol inte att man skulle ordna dessa ting på det sätt, som man då bestämde sig för, eller rättare som man nu har tvingats att göra. Men sedan riksdagen beslutat att bygga här på Norrbacka, så skall riksdagen också bygga, och vi skola naturligtvis inte förhala detta byggande längre än vad som är absolut nödvändigt. Jag delar inte på den punkten herr Roséns uppfattning. Vi ha sedan länge konstaterat, att vi måste ordna för de medicinska disciplinerna. Vi ha beslutit att göra det, och vi skola fullfölja detta beslut. Det är min ena utgångspunkt.

Den andra utgångspunkten är, att vi skola bygga efter det billigaste systemet — således efter blockhussystemet. Den erfarenhet, vi redan ha fått genom den sista överarbetningen, visar ju, att man gör storartade besparingar, därest man följer det byggnadssättet. Det är därför, jag anser, att det i närvarande stund kräves, först och främst, att vi inte börja bygga förr än vi äro fullt på det klara med att vi genom vårt byggnadssätt inte stänga vägen för oss, så att vi en vacker dag upptäcka, att nu voro vi åtskilligt dumma, när vi började bygga, som vi gjorde; vi skulle allt ha börjat på annat sätt. Och vi ha ju, som herr Westman påpekade, god tid. Det är, som ordspråket säger, ännu ingen ko på isen.

Vidare bör riksdagen inte genom sitt handlingssätt i dag släppa greppet om detta stora byggnadskomplex, som kommer att kosta så oerhört mycket pengar och som är det största byggnadsföretag, som jag 1 mitt liv varit med om att besluta i. Jag skulle dessutom tro, att det inte är svårt att ordna det så, att ingenting försittes. Det behövs bara, att man vid sidan om den byggnadskommitté, som skall ha hand om bygget, sätter en annan kommitté, en verklig hesparingskommitté, som tar upp spörsmålet på nytt, synar det och försöker komma till det bästa resultatet. Samt vidare, att man inte börjar att bygga på huvudkomplexet. Skulle jag personligen få rekommendera någonting, skulle det vara, att man börjar med den radioterapeutiska kliniken. Jag tycker, att den vid överarbetningen fått en omläggning, som är bra, och att man på grund därav inte kan komma längre med den byggnaden.

Jag har alltså, som de som ha läst ärendet kunnat finna, inte alldeles samma utgångspunkter som herr andre vice talmannen och hans medreservant, men i många stycken har jag ungefär enahanda uppfattning, och då det i dag gäller att inte i onödan splittra sig på flera olika förslag, kommer jag, herr talman, att yrka bifall till den av herr andre vice talmannen och hans medreservant vid ärendet fogade reservationen.

I detta anförande instämde herr Björck, Wilhelm, och herr Wagnsson.

2. Israel Holmgren (Frisinnade folkpartiet, man)

Herr talman! Det byggnadsföretag, som kammaren skall besluta om i kväll, har en ytterligt stor betydelse. Det har en mycket stor betydelse för den medicinska undervisningen, det har en mycket stor betydelse för den medicinska forskningen i vårt land, och det har slutligen också en mycket stor betydelse såsom ett förebildligt sjukhus för utvecklingen av vår sjukhusvård i landet. Jag vill i detta avseende alldeles instämma i vad herr Westman sade i sitt anförande för en stund sedan, att det är utomordentligt

viktigt, att detta sjukhus blir så konstruerat, att det kan betraktas såsom en förebild för de ehuruväl mindre sjukhusanläggningar, som i övrigt göras hos oss. Jag kan alltså icke instämma i vad herr Rosén i detta avseende för en stund sedan sade, då han ansåg, att detta sjukhus icke behövdes ur den medicinska undervisningens och utvecklingens synpunkt. Det gör det nog.

Herr Rosén befarade också, att det skulle medföra en ökad tillströmning på läkarbanan, så att det skulle uppstå ett läkarproletariat, men jag tror inte alls, att det har något som helst inflytande på tillströmningen till läkarbanan — den regleras av de ekonomiska förhållanden, som möta de unga läkarna, fast dessvärre på grund av den långa studietiden inflytandena i den ena och andra riktningen först komma ganska långt efter de faktorer, som framkallat dem.

Inte heller kan jag instämma med herr Rosén, då han framhöll, att de kostnader, som nu nedläggas för serafimerlasarettets modernisering, skulle vara någonting, som står i vägen för detta företag, ty det är ju inte så, att det är meningen, att det, som vi nu skola besluta att bygga, skall utgöra en ersättning för serafimerlasarettets kliniker, såsom jag tyckte herr Rosén menade det. Det är bara en av de kliniker, som för närvarande ligga vid serafimerlasarettet — den oftalmiatriska — som skulle komma med i detta nybygge, som vi nu skulle besluta om. Jag har således för min del på grund av den mycket stora betydelse, som jag måste tillmäta detta byggnadsföretag, inte från början och inte heller nu varit rädd för att det skulle nedläggas stora kostnader på det.

Vad jag däremot ansett vara av utomordentlig betydelse är, att när man lägger ned så stora kostnader, man också får någonting, som är så ändamålsenligt som möjligt. Detta var, sade herr Bergqvist i sitt anförande nyss, också för honom det väsentliga, att ändamålsenligheten

skulle i första hand vara det avgörande och inte kostnaden. Så har det varit för mig också, men just därför att jag inte funnit detta byggnadsförslag vara verkligt ändamålsenligt, har Jag från början opponerat mig mot det. Redan då det första gången framlades för riksdagen 1926, opponerade jag mig mot det. Jag hade då varit medlem av 1919 års sjukhusbyggnadskommitté, eller hur den nu kallades, och hade som medlem i den reserverat mig mot det förslag, som framlades för riksdagen 1926. Jag reserverade mig mot själva planläggningen, emot organisationen, emot drifttekniska anordningar i det hela taget och emot en hel mängd principiellt viktiga saker. Riksdagen beslöt då, att detta förslag skulle omarbetas och tillsatte en kommission för det ändamålet. Den kommissionen adjungerade med sig som sakkunniga just de personer, som hade ansvaret för det första förslaget, som skulle omarbetas. Redan 1926, då man fick veta vilka, som hade adjungerats av kommissionen såsom sakkunniga, visste man, att det nya förslaget, som skulle framkomma, inte skulle komma att förverkliga riksdagens önskemål om en omläggning av det hela. Det gjorde det inte heller, utan det förslag, som kom fram till förra årets riksdag, var, om man frånser från vanföreanstalten och den radiologiska kliniken, som hade tillkommit eller förändrats i sin planläggning, i all huvudsak samma förslag, som riksdagen begärt att få omarbetat 1926. 1930 års riksdag begärde nu att få en överarbetning till stånd av det förslaget.

Jag sade här i kammaren vid förra årets riksdag ett par saker om det förslaget, som jag skall be att få påminna om nu. Jag sade: »Amledningarna till dessa enligt min mening betydande bristfälligheter i förslaget ligga däruti till väsentlig del, att de, som utarbetat förslaget, icke tagit tillbörlig hänsyn till de moderna strömningar inom sjukhusbyggnadskonsten, som för närvarande göra sig gällande och vilket kunnat medföra ett betydligt förbilligande av kostnaderna. Skall detta sjukhus byggas enligt det föreliggande förslaget,

kommer det därför att redan vid sin invigning vara ett föråldrat sjukhus i viktiga avseenden.» Det var mitt anförande i den punkten vid förra årets riksdag, och jag anser, att det kan upprepas på samma sätt också nu. Det är ju samma personer, som fingo i uppdrag att överarbeta förslaget, och man kan ju inte vänta sig, att de skulle göra den principiella omläggning av förslaget, som är den enda möjligheten för att få några väsentliga förbättringar både i fråga om ändamålsenligheten och i fråga om kostnaderna.

Herr Bergqvist sade i sitt anförande för en stund sedan, att riksdagen beslöt att taga det förslag, som framlades till 1930 års riksdag, försåvitt inte någon utväg anvisades, som otvetydigt anvisar ur statens synpunkt otvivelaktiga fördelar. Något sådant förslag har inte framlagts, sade herr Bergqvist. Nej, tacka för det, eftersom det uppdrogs åt samma personer, som utarbetade det förra förslaget, att komma med en omarbetning, är det ju klart, att de inte gjorde några principiella omläggningar i förslaget.

Mina anmärkningar mot förslaget 1930 återfinnas i den motion, som jag vid 1930 års riksdag framlade. Dessa anmärkningar ha sedermera av kommissionens experter, professorerna Key

och Gösta Forssell, besvarats i det betänkande, som 1930 avgavs av 1930 års sjukhuskommission. TI detta betänkande ha de kritiserat mina anmärkningar. Jag svarade på detta i en skrivelse till Konungen, som finns återgiven i min motion. Sedan ha återigen i en skrivelse till statsutskottet professorerna Gösta Forssell och Key kritiserat denna min kritik av dem. Således är det de, som haft sista ordet, och det skulle nu vara min tur att börja omigen, men jag ber kammaren att inte oroa sig för att så kommer att ske. Jag tänker nämligen inte upptaga kammarens tid med sådan polemik. Det är, som att strida mot en månghövdad hydra. Hugger man av ett huvud, växer det genast upp igen två likadana på samma ställe. Därför tjänar en polemik i detta fall rakt ingenting till.

Jag vill säga, att på sista tiden har jag fått medhåll i min kritik av detta förslag. Jag har förut stått ensam om denna kritik i bortemot tio år, under vilken tid jag ju hållit på och kritiserat. Jag har fått medhåll av en ingenjör eller en arkitekt, som lär av kommissionen ha tillkallats för att avge utlåtande eller säga sin mening om förslaget. Jag har sedan också fått medhåll av de tyska experter på sjukhusbyggnader, som av honom ha anmodats att yttra sig. Jag vill förklara, att jag inte har det ringaste att göra med tillkomsten av dessa uttalanden och inte alls kände till dem, förrän de redan förelågo, men naturligtvis är jag glad att se, att i många väsentliga stycken säga de alldeles detsamma, som jag sagt hela tiden ända från början. Man har försökt förringa betydelsen av dessa tyska experters uttalanden genom att framhålla, att de kunna inte ha så noga reda på förutsättningarna för detta sjukhusföretag, att de skulle kunna yttra sig på ett värdefullt sätt. Jag undrar, om det inte huvudsakligen är en fras, när man säger så. Jag skulle t. ex. vara mycket intresserad av att få höra, vad det skulle kunna anges för särskilda omständigheter, som föreligga vid detta sjukhusföretag och som skulle göra, att det är nödvändigt att här placera **sköterskornas³** bostäder på avdelningarna och inte i ett särskilt personalhus, då det vid andra sjukhusbyggnader går för sig och är lämpligt. Jag skulle vidare vara intresserad av att höra vad det kan anges för skäl för att vid denna sjukhusbyggnad allehanda kliniker måste placeras såsom fristående byggnader för sig, då det inte behövs på andra håll. Jag tror inte, att man kan komma fram med några särskilda omständigheter i det fallet — det kan ju vara andra avseenden, där experternas uttalanden inte fullt passa in på våra förhållanden.

Jag har vid innevarande års riksdag väckt en motion, där jag hade tänkt mig, att man skulle kunna åtminstone få kammarens bifall till en del detaljändringar i förslaget, som i alla fall äro nog så viktiga. En sådan detaljänd-

ring är just den, som rör **sjuksköterskornas³** bostäder. Vi ha nyss hört förste vice talmannen på ett mycket vältaligt sätt utlägga olägenheterna ur humanitär synpunkt av att **sköterskorn a³**, såsom hittills har brukats hos oss, bo i sina avdelningar eller strax intill. Jag anser, att den framställning, han gjorde av de där förhållandena, är ur facklig synpunkt fullkomligt riktig. Man tycker, att det inte borde vara så svårt att inse, hur olämpligt det måste vara för **sköters korna³** själva att bo på det sättet. De arbeta hela sin dag omgivna av sjukdom, nöd och lidande, och när det slutat sitt arbete, skola de bo mitt uti detta. Kan detta vara rimligt?

Det anföres, att det behövs för att de måste vara till hands. Det är ett misstag. Det behövs inte alls, försåvitt den, som avlöser **sköterskan³**, innehar tillräcklig kompetens och personalen är tillräckligt stor. Då behövs det inte alls, att **hon²** där finns boende, utan **hon²** kan mycket väl bo i ett särskilt bostadshus med alla de fördelar för **hennes²** psykiska och kroppsliga hälsa, som det medför. Man ser, som förste vice talmannen framhöll, hur våra **sköt erskor³** 1 alldeles för stor utsträckning bli i förtid utslitna. De bli andligen förkrympta. De bli förslitna både andligen och kroppsligen långt tidigare än som vore nödvändigt, om deras arbetsförhållanden organiserades på ett mera lämpligt sätt.

Jag har också i min motion yrkat på att vid det nya sjukhuset skulle redan nu i den första etappen byggas polikliniker eller anordnas polikliniker för de kliniska fack, för vilka inte kliniker byggas i första omgången. Jag har gjort det därför, att det för förverkligandet av den enhetstanke, som är en av de viktigaste anledningarna till hela företaget, måste vara synnerligen fördelaktigt att redan från början få tillgång till sakkunskap i alla de olika specialiteterna och inte för en hel del av dem behöva avvakta senare etapper. Detta skulle vinnas, om man gör polikliniker.

Nu säger utskottet, när det behandlar den här saken på sid. 30, att man kan inte gå med på detta, därför att dessa polikliniker endast komma att utgöra ett provisorium. Ja, varför skola de vara ett provisorium? Jo, därför att kommissionen har tänkt sig, att de senare tillkommande klinikerna skulle läggas såsom fristående byggnader och att var och en av dem skulle vara försedd med sin poliklinik. Det är utan tvivel organisatoriskt alldeles felaktigt, och jag begriper icke, varför man nödvändigt skall hålla på det. Det är ju ur samarbetets synpunkt mycket lämpligare, att alla polikliniker ligga tillsammans.

Jag har hört den anmärkningen framställas mot detta, att t. ex. en sådan poliklinik som polikliniken för sinnessjuka skulle inte lämpligen kunna ligga tillsammans med de andra voliklinikerna i det centrala blocket. Jo, visst kan 'den det. Jag har verkligen någon erfarenhet därom, ty vi ha på serafimerlasarettet sedan ganska många år tillbaka en poliklinik för sinnessjuka, som vi ha just tillsammans med de andra poliklinikerna i samma byggnad, utan att någonsin någon olägenhet därav varit märkbar.

Det, som jag för min del anser vara en av de största bristerna ur ändamålsenlighetens synpunkt i det här förslaget är, att den medicinska kliniken har blivit så litet tillgodosedd. »Medicinen», som det kallas, d. v. s. de invärtes sjukdomarna, är det ämne, som är allra viktigast för de blivande läkarnas utbildning. Det finns ingen meningsskiljaktighet om den saken. Det erkännes av alla. Det är det viktigaste och centrala ämnet vid undervisningen. Det är också det centrala ämnet i den kliniska forskningen. Under sådana förhållanden är det väl ganska klart, att när det gäller att bygga ett universitetssjukhus, borde synnerlig hänsyn tagas just till den invärtes-medicinska klinikens behov. Så har inte alls skett i detta förslag. Jag har redan påpekat en hel del bristfälligheter, som finnas i detsamma. Jag vill här bara

påminna

om ett par stycken, nämligen att i förslaget har man inte tänkt på att med den medicinska kliniken förena varken en tuberkulosavdelning ej heller en avdelning för reumatiska sjukdomar. Det är saker, som jag förut påyrkat. Beträffande tuberkulosavdelningen har jag påyrkat det ända sedan 1926, och beträffande den reumatiska avdelningen har jag påyrkat det under den förberedande behandlingen före framläggandet av det förslag, som kom till förra årets riksdag. Det är således väl känt för kommissionen.

Nu säger professor Key i sin inlaga till statsutskottet, att jag godkänt ritningarna till den medicinska kliniken. Det är väl i alla fall väl bekant för Key, att dessa principiella anmärkningar, som jag nu talar om, ha av mig framställts hela tiden. Jag har alltid hållit på dem. Hur man då kan säga, att jag har godkänt ritningarna, förstår jag icke.

Vad angår nu tuberkulosavdelningen vid sjukhuset, veta vi ju alla, att tuberkulosen är en av de allra viktigaste, kanske den allra viktigaste, av våra folksjukdomar. Det är då också klart, att undervisningen i tuberkulos för de blivande läkarna är en mycket viktig del av undervisningen. Den undervisning, som de nu få i tuberkulos, är inte tillfredsställande. Det har kommit klagomål sedan många år från våra sanatorieläkare, från våra tuberkulosläkare, att de unga läkarna äro för klent utbildade ifråga om igenkännande och behandling av lungtuberkulos. Ja, dessa anmärkningar mot undervisningen äro alldeles riktiga. Det sammanhänger med att vi inte ha haft några tuberkulosavdelningar förenade med våra nuvarande kliniker. Därför har man inte kunnat ta in tuberkulossjuka annat än i mycket begränsad utsträckning. Den undervisning, som de studerande få i tuberkulos för närvarande, få de så gott som uteslutande under den propedeutiska tjänstgöringen, som sker på S:t Eriks sjukhus här i Stockholm under mycket otillfredsställande förhållanden. Hur det skall ordnas med detta, när sjukhuset S:t Erik lägges ned av Stockholms stad, känner jag icke till, och jag vet inte, om kommissionen har tänkt sig någon planläggning av detta. Men man kan väl inte annat än säga, att Just nu skulle det vara rätta tillfället att se till att en tuberkulosavdelning förenas med det nya sjukhuset, så att undervisningen förbättrades och att den propedeutiska undervisningen förlägges dit också. Jag har påyrkat allt detta men utan minsta effekt.

Vad nu angår en avdelning för reumatiska sjukdomar, således för ledgångsreumatism i dess olika former, veta vi ju också, att ledgångsreumatism jämte tuberkulos och kräfta är den viktigaste av våra folksjukdomar. Den ger anledning till en mycket stor del av all invaliditet i vårt land. Jag minns nu inte riktigt siffrorna, men jag skulle tro, att minst 20 eller 25 procent av all invaliditet härleda sig därifrån. Jag kanske missminner mig, men i varje fall är det en mycket stor del av all invaliditet, som är beroende därpå. Det är således mycket viktigt, att man kan undervisa på ett tillfredsställande sätt i fråga om de reumatiska sjukdomarna. Det kan man inte göra, ifall man inte har möjlighet att taga in tillräckligt många sjuka av den kategorien i en sådan avdelning. Det är således mycket önskvärt att få en sådan avdelning i detta nya sjukhus, dessutom också ur den synpunkten, att man därigenom skulle gagna den

vetenskapliga forskningen av dessa sjukdomar, en forskning, som för närvarande är aktuell överallt i världen och som sammanhänger med, att man känner för litet om dem. Man har först nu förstått deras stora betydelse och vet, att man känner för litet till om dem för att kunna bemästra dem.

Det framhålles, att det behövs inte någon tuberkulosavdelning eller någon reumatisk avdelning vid sjukhuset, därför att man kan ändå på den medicinska kliniken taga in de sjuka. Naturligtvis kan man göra det, men det blir i alldeles otillräcklig utsträckning, och dessutom kräves det, om det skall vara ändamålsenligt, att dessa avdelningar äro ordnade för sitt speciella ändamål.

Vad angår nu den ekonomiska sidan av saken, att förlägga en avdelning för reumatiska ledsjukdomar till det nya sjukhuset, vill jag påminna om, hur pensionsstyrelsen redan nu har ordnat med, som jag tror, 5 sådana avdelningar vid olika sjukhus här i landet, och det finansieras på det sättet, att landstinget får av pensionsstyrelsen ett amorteringslån, som skall amorteras på 30 år. För dessa pengar bygges då denna avdelning. Vad sedan beträffar driftkostnaderna, går det till så, att kostnaderna för dessa avdelningar slås ut på underhållskostnaderna för hela sjukhuset, varefter pensionsstyrelsen betalar den del av driftkostnaderna, som inte täckas av patientinkomsterna. Det är således en fullkomligt gratis drift. Vidare är det inte nog med detta, utan pensionsstyrelsen ger också ett tillägg, som är tillräckligt att betala ränta och amortering av lånet. Således kan man säga, att det finns väl inte något billigare sätt att åstadkomma en sjukavdelning och en viktig sjukavdelning än just detta sätt. Varför vill då inte sjukhuskommissionen gå in för att i sitt förslag taga med någonting, som vore så lämpligt och så lätt att ekonomiskt åstadkomma”? Ja, jag begriper inte detta.

Jag har sett i den kungl. propositionen, att statsrådet är betänkt på att låta verkställa en utredning, om det inte också är lämpligt att i den första etappen komma med en psykiatrisk klinik och eventuellt också en pediatrisk klinik. Jag blev mycket glad, när jag fick se detta. Det är ju detsamma, som jag påyrkat sedan 1926 utan den ringaste effekt hittills. Jag skulle då vördsamt vilja hemställa till herr statsrådet, om det inte skulle kunna låta sig göra att i samband med den utredningen också låta verkställa en utredning om, ifall inte en avdelning för reumatiska sjukdomar och en avdelning för tuberkulos kunde i första etappen utföras i samband med den medicinska kliniken, så att de kunde stå till tjänst för den undervisning, som där skall lämnas.

Då det nu gäller frågan, hur man skall rösta här, kommer jag att be att få yrka bifall till min motion, herr talman, och jag kommer, då det gäller huvudvoteringen, ifall den kommer att stå mellan utskottets förslag och herr Nilssons i Gränebo reservation, för min del att rösta för reservationen. Det gör jag därför, att jag anser mig på det sättet bäst gagna den svenska medicinen. Det är den enda möjligheten, som jag kan se, för att man skulle kunna få genom förda de förbättringar, som jag för min del anser vara högst viktiga, i detta förslag.

Herr Bergqvist vill inte medge, att några egentliga förbättringar här skulle kunna vara möjliga, och han kritiserade bland annat den plan, som statsutskottet hade fått för sig framlagd av, om det nu var, ingenjör Cederström eller vem det nu var. Han gjorde sig till exempel ganska lustig över anordningen med kökets placerande på taket, som här var föreslaget. Det är emellertid inte något lustigt, utan det är i stället något, som är utomordentligt praktiskt och som redan finns utfört på många håll med stor fördel. Jag tror, att mycket skulle stå att vinna både ur ändamålsenlighetens synpunkt och ur ekonomisk synpunkt, om man läte en sådan grundlig omarbetning, en sådan principieli omläggning av hela förslaget eventuellt komma till stånd.

Man kan ju säga, att vi få väl lov att någonsin få ett slut på den här frågan, och det önskar ingen hellre än jag. 'Den har i själva verket varit aktuell ända sedan 1914, men jag säger i den här saken på samma sätt som herr Fredrik Ström i förmiddags i en annan fråga — ehuru jag förändrar det så, att det passar nu — att jag anser det vara bättre att vänta ett eller annat år och få ett riktigt bra förslag än att taga ett, som inte är riktig bra, även om det brådskar. Jag tror inte, att det behöver bli så förfärligt lång väntetid. Det är kanske för sangviniskt att tro, att det kan komma till nästa riksdag, men även om det skulle dröja ett år till, är detta inte så farligt. Det är inte, som herr Bergqvist sade, så att frågan kastas ut i det ovissa. Så pass starkt som riks-

dagen har engagerat sig i denna fråga, är det väl inte det ringaste tvivel om att det kommer till stånd ett sjukhus av den omfattning, som här är önskvärd. Det behöver inte vara det ringaste tvivel om den saken. Här är ju bara fråga om att få det så ändamålsenligt som möjligt.

Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till min motion.

3. Ivan Pauli (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Denna fråga har haft ett ganska märkvärdigt och oblitt öde. Den har, som herr Holmgren nyss påpekade, blivit utredd under många år. Den har genomgått ett stort antal sakkunnigkommittéers behandling, och den har varit föremål för beslut i riksdagen i fjol. Varje gång den har varit före, har den mött motstånd. När den förelåg i riksdagen 1926, mötte den motstånd, därför att man var oense om tomten. Man ville då inte ha Ladugårdsgärde, därför att det var en alldeles för dyr tomtmark, och riksdagen beslöt också, att sjukhuset skulle läggas annorstädes. Sedermera har riksdagen i fjol slutgiltigt fattat det beslutet, att det nya undervisningssjukhuset skall byggas på Norrbacka. Riksdagen uppställde då två önskemål, nämligen dels att man skulle underkasta byggnadsförslaget en överarbetning för att få det billigare, och dels att man skulle höra sig för med Stockholms stad, om den inte skulle vilja belägga flera platser än dem, staden redan förbundit sig till. Dessa två önskemål ha blivit uppfyllda. Likväl går man nu från olika håll till anfall mot detta förslag och detta av de mest skilda motiv. Å ena sidan ha vi herr Rosén, som utan egentlig sakmotivering yrkat avslag på alltihop av mycket allmänna grunder. Vidare ha vi bondeförbundsreservanterna, som önska

en ny utredning om byggnadsplanen, därför att de vilja ha det hela billigare. Herr Olof Olsson har ju även anslutit sig till denna reservation. Vidare ha vi herr Holmgren, som inte talar så mycket om billigheten, utan mest intresserar sig för att få vissa avdelningar med snaraste dit upp till Norrbacka, vilka inte i det föreliggande förslagit blivit förlagda dit. Han vill således utöka bygget, medan man från bondeförbundshåll tycks vilja inskränka det så mycket som möjligt.

Jag skall ett ögonblick återgå till utgångsställningen. Stockholms stad har inte velat belägga flera platser än de 315, som staden redan förbundit sig till genom ett preliminärt avtal. Man har även vänt sig till Stockholms län och frågat, om länet inte ville taga flera än de 110 platser, som det bundit sig för. Både staden och länet ha sagt, att de äro nöjda med det antal platser, som de redan ha. Beträffande de 55 reservplatser bland de 204 s. k. utomlänsplatserna — alltså sådana som äro avsedda att beläggas med patienter utanför Stockholms stad och Stockholms län. — vilka skulle kunna avstås åt staden och länet, ha både staden och länet genom sina representanter förklarat, att de anse, att dessa 55 platser synnerligen väl behövas för det från början avsedda ändamålet. I själva verket ligger det i Stockholms stads eget intresse, att dessa platser komma att användas för detta ändamål, därför att Stockholms stads egna sjukhus för närvarande få taga emot patienter från landsorten, vilket både är dyrt för patienterna och vållar staden extra kostnader. Stadens representanter förklarade dessutom, att med den utmärkta läkarvård och förträffliga utrustning, som detta sjukhus kommer att få, kommer det helt säkert aldrig att sakna tillströmning av patienter såväl från staden som från landsorten. Detta förtjänar att anföras, därför att man nu på sina håll förmenar, att patientantalet är för stort. Detta patientantal har avvägts med tanke på såväl sjukvårdens som undervisningens behov. Om man inskränker antalet patienter på de olika avdelningarna, får man ju komma ihåg, att detta direkt drabbar de sjuka själva. De komma då att så många fler gånger behöva underkasta sig undersökning av läkarekandidater vid den medicinska undervisningen, och ju oftare detta upprepas, desto mer betungande måste det bli för de sjuka. Här har man således ett rent humanitärt skäl för att inte ytterligare beskära patientantalet. Jag tror för övrigt inte att denna fråga om plats-

antalet närmare behöver beröras, och den har ju inte heller hitintills spelat nå- Ang. gon framskjuten roll i diskussionen. uppföras ed

Bondeförbundsreservanterna, vilkas talan i främsta rummet har förts av husjukhuset. vudmotionären, herr Westman, ha riktat flera ganska skarpa invändningar emot (Forts.) det föreliggande, av statsutskottet tillstyrkta förslaget. De påstå, att däri inte har tagits tillräcklig hänsyn till moderna sjukhustekniska synpunkter och till behovet av driftsundersökningar. Jag är ju inte på något sätt någon auktoritet i detta avseende. Jag kan endast som intresserad lekman säga, att sedan jag tagit kännedom om kommittébetänkandet och om propositionen i denna fråga, så har jag fått det bestämda intrycket, att de sakkunniga, som haft detta om hand, mycket noga ha undersökt frågan om driften och driftkostnaderna och anpassat planläggningen av byggnaderna just efter dessa synpunkter. Vi ha på utskottsavdelningen

haft två olika föredragningar av så eminenta medicinska sakkunniga som professorerna Key och Forssell, vilka medarbetat vid förslagets utformade, och de ha övertygat oss — jag undantar förstås de reservanter, som voro närvarande vid dessa föredragningar — om att de verkligen lagt en noggrann undersökning av just driftssynpunkterna till grund för sitt byggnadsförslag.

Nu säger man här, att man genom en ändrad planlösning skulle kunna spara ytterligare. Jag vill påminna om, att man redan nu genom minskning av byggnadskuben nått upp till en besparing på åtskilligt över 2 miljoner kronor. Man kan sålunda inte påstå, att riksdagens önskemål ej blivit tillgodosedda — de ha tvärtom, måste jag för min del säga, blivit i oväntad grad tillgodosedda.

Jag kan inte riktigt fatta det resonemang, som min ärade vän herr förste vice talmannen lade till grund för sin kritik av de sakkunniga, nämligen att det båda gångerna varit samma sakkunniga, och att dessa vid överarbetningen av sitt eget tidigare förslag, genom att till det yttersta pressa utrymmena utan att likväl frångå ändamålsenligheten, visat sig kunna vinna denna avsevärda besparing. Jag kan inte finna annat än att detta är en mycket respektabel prestation, för vilken de äro värda allt erkännande. Nu resonerar man emellertid så, att har man redan kunnat spara 2 miljoner, så bör man kunna spara ytterligare en hel del miljoner. Det sättet att resonera påminner mig om en gammal historia om en snål torpare, som hade en häst. Han tyckte, att hästen inte skulle behöva ha så förfärligt mycket att äta, utan att han borde kunna spara in på fodret. Och så knappade han in på foderransonen mer och mer, och hästen levde visserligen, men blev allt magrare, och till slut dog den. Då sade torparen: »Det var bra synd, att han skulle dö just nu. Hade han fortsatt att leva, hade Jag nog vant honom av med att dricka också!» Liksom denna stackars häst inte tålde vid att få sin foderranson inknappad hur mycket som helst, utan det fanns en gräns, över vilken man inte kunde gå, så skulle jag tro, att vi även här ha nått den gräns, där sparsamheten kommer i en ohjälplig konflikt med ändamålsenligheten. Och vi ha för vår del i utskottet blivit övertygade om, att man i stort sett här lyckats på ett mycket tillfredsställande sätt tillgodose både sparsamheten och ändamålsenligheten. Utskottet har dock icke velat undandraga riksdagen möjligheten att under själva byggnadsarbetet hitta på detaljer, där ytterligare besparingar kunna göras. Detta har också med största eftertryck betonats i utskottets utlåtande, och jag ber att få påminna om, som utskottet också gör, att denna fråga ju varje år kommer tillbaka inför riksdagen, i och med anvisandet av de årliga anslagen. Det förhåller sig således inte alls så, som herr förste vice talmannen sade, att riksdagen genom att i dag besluta i enlighet med utskottets förslag helt släpper sitt grepp över frågan. Det gör riksdagen ingalunda; riksdagen har kvar greppet under varje år, som kommer.

Nu mena emellertid reservanterna att man från början bör göra ett radikalt grepp och ändra själva byggnadsplanen. Jag vill då till en början påpeka en rätt egendomlig brist på överensstämmelse i reservanternas resonemang. De mena,

att vi nu trots detta skulle kunna bevilja pengar till vissa förarbeten, och de nämna då bl. a. vägarbeten och ledningsanläggningar inom tomtområdet. Jag har för min del blivit mycket förvånad över detta. Ty har man inte gjort klart för sig, var man skall placera de olika byggnadskropparna, så blir det väl ganska svårt att bestämma, var vägar och ledningar och rörgravar skola gå fram, och var terrasseringar skola företagas. Sådant kan givetvis icke ske, utan att man har byggnadsplanen fullt klar för sig. I denna punkt innehåller reservationen sålunda en uppenbar motsägelse. Nu förespeglar man emellertid, såväl från reservanternas sida som från herr Holmgrens, att om man bara förkastar den nuvaranade byggnadsplanen, i varje fall för huvudkomplexet, och gör en ny utredning, så kommer man att få ett alldeles utmärkt förslag, som är både ändamålsenligt och billigt. Jag får bekänna, att jag beundrar den optimism, som ligger bakom ett sådant antagande. Men Jag förstår inte alls, vad denna optimism grundar sig på. Jag beklagar, mina herrar, att ni inte hade tillfälle att höra det resonemang, som fördes på avdelningen av ingenjör Cederström och arkitekt Birch-Lindgren, vilka författat de inlagor, som skattebetalarnas förening skickat kring till kammarens ledamöter och vilkas synpunkter huvudsakligen gå igen i reservationen. Kammaren hörde tyvärr inte de anföranden, som höllos av dessa herrar, och det bemötande, som de fingo från de sakkunniga, som arbetat 1 denna fråga. Jag tror inte, att det sedan var så mycket kvar av den överlägsna ändamålsenligheten och prisbilligheten i dessa herrars projekt. Vi frågade dem direkt, vad det var för förslag, som de hade att framlägga som alternativ till det föreliggande, och vi fingo till svar, att de i själva verket icke hade något sådant förslag. Det hänvisades endast till att det pågår en utredning angående Stockholms stads sjukhusbygge på Söder, och denna utredning väntade man skulle ge ett mycket gott resultat; därför borde riksdagen invänta detta resultat och sedan tillgodogöra sig de vunna erfarenheterna. Det är i alla fall väl mycket begärt, tycker jag, att bara därför att man förespeglar att en sådan kommunal utredning skulle kunna ge ett gott resultat, skall riksdagen efter alla dessa grundliga undersökningar uppskjuta sitt eget ståndpunktstagande i fråga om Karolinska sjukhuset.

Sedan har man emellertid kommit med något mera positiva linjer. Statsutskottets ledamöter fingo strax före utskottsbehandlingen mottaga ett dokument, som jag har här och som innehåller dels en grov skiss av det nuvarande byggnadsförslaget, dels en lika grov skiss av ett av ingenjör Cederström uppgjort alternativt byggnadsförslag och dels ett utlåtande av tre tyska herrar, av vilka åtminstone den ene, dr Alter, är gammal korrespondent till ingenjör Cederström. Det är alldeles tydligt, att han i många avseenden varit ingenjör Cederströms auktoritet, och det är under sådana förhållanden inte så egendomligt, att det råder stor överensstämmelse mellan denne dr Alters utlåtande och ingenjör Cederströms förslag. Det har sagts av en talare, att han inte kan förstå i vad avseende dessa utlänningars synpunkter skulle avvika från de förutsättningar, på vilka vårt eget svenska sjukhus måste bygga. Jag skall beröra en av dessa avvikelser. Det framgår av den nyssnämnda Cederströmska skissen, att i stället för den enhetliga fasad, som man enligt det nu föreliggande förslaget avsett att bygga, har herr Cederström byggt en rad flyglar, som sticka ut så gott som rakt mot söder. Detta vill med andra ord säga, att man i stort sett berövar denna fasad södersol. Den får

södersol endast då solen står mitt för fasaden, men så snart solen befinner sig i mera sned riktning, komma dessa flyglar att kasta långa skuggor mot huvudfasaden. Detta är någonting, som vi svenskar, som sannerligen inte ha för mycket av sol, måste betrakta med mycket stor betänksamhet. Man kan förstå, att i de södra länderna, där man har övernog av solsken, det kanske rentav kan behövas att skydda sjukhusen för alltför stark sol-

belysning och att man därför kan gå tillväga på detta sätt. Men här i Sverige Ang.

kan man knappast anse det vara ett idealiskt byggnadssätt. En annan synpunkt, uppförande av arolinska

som förste vice talmannen betonade mycket starkt, är att man vill ha det nya sjukhuset.

byggnadsförslaget i enlighet med det s. k. blocksystemet. Det innebär, att man = (Forts.)

så mycket som möjligt koncentrerar byggnaderna och bygger ihop dem. Det

låter från kritikens sida nästan, som om de nuvarande sakkunniga icke alls skul-

le ha tänkt på denna sak. TI själva verket ha de underkastat den en grundlig

prövning. I propositionen, sid. 30 och följande, återfinnes just ett resonemang

från deras sida om ett sådant blocksystem med mycket höga byggnader, och där

påvisas, att ändamålsenligheten av ett sådant byggande i höjden upphör vid en

viss höjd. Beträffande byggnadskostnaderna för bostadshusen i Stockholm har

en utredning gjorts, av vilken framgår, att den ekonomiska gränsen, i vad det

gäller det lönande i att bygga i höjden, ligger vid sex eller sju våningar. Och

detsamma torde gälla sjukhusen. En annan sak har påpekats beträffande dessa

höga blockhus, och det är det ytterst betänkliga i brandfaran. Man kan inte

bygga hur höga brandstegar som helst, och brandchefen i Stockholm har för-

klarat, att den högsta höjd, som kan tillåtas för ett sjukhus, är 24 meter upp

till den översta våningens fönsterbröstning, detta med hänsyn därtill att i hän-

delse av eldsvåda möjligheten att med stegar rädda människor eljest äventyras.

Det finns alltså vissa gränser satta för detta byggande uppåt, och det är just

med hänsyn till dessa gränser, som de sakkunniga ha avpassat byggnadernas

Vidare säger man, att man bör samla alla klinikerna under ett tak. Jag förmodar att även de, som förfäkta denna mening, likväl icke anse, att det bör gälla 1 bokstavlig mening. Det visar sig t. ex., att inte ens den mest koncentrerade sjukhusbyggnad, som finns i hela världen, nämligen Medical Center i New York, fullt konsekvent genomfört systemet att lägga alla klinikerna i en byggnad. Kliniken för sinnessjuka exempelvis är en egen fristående byggnad, likaså nervkliniken, och man har även tänkt sig andra fristående byggnader. Jag vill fråga, om det vore så särskilt lämpligt, därest Konradsbergs psykiatriska klinik flyttades till Norrbacka, att då lägga detta sinnessjukhus under samma tak och omedelbart sammanbyggt med de övriga byggnaderna. Jag tror, att det finns goda skäl, som icke närmare behöva utvecklas, för att lägga det något avskilt. Och om vi tänka på den pediatriska kliniken, barnsjukhuset, om vilket herr Holmgren nyss uttalade en önskan, att det skulle förläggas till Norrbacka så snart som möjligt — något som jag tror, att vi alla kunna instämma i — har man tänkt sig, att detta barnsjukhus skulle placeras uppe på en höjd, där det ligger fritt och bättre kan tillgodose de särskilda krav, som böra ställas på ett barnsjukhus. Jag har med dessa exempel velat erinra om att man inte så där utan vidare kan slå ihop alltsammans under en hatt. Man fyller därmed icke ändamålsenlighetens krav.

När nu herr förste vice talmannen särskilt klandrar de sakkunniga, för att de icke talat om, huru man en gång, när serafimerlasarettet skall flyttas till Norrbacka, skall placera det, så vill jag säga, att det knappast är rimligt att begära, att man 30 år 1 förväg skall kunna uppgöra planritningar och i detalj visa, hur en lämplig anslutning skall ske. Riksdagen har ju själv bestämt, att det nuvarande serafimerlasarettets sjukhusbyggnad skall användas i 30 år till. Jag vill fråga: kan någon av herrarna profetera om hur det nuvarande serafimerlasarettet kommer att se ut om 30 år? Vem kan nu förutsäga, vilka förändringar på det byggnadstekniska, sjukhustekniska och medicinska området som så långt fram 1 tiden komma att inträffa? Nu menade måhända herr förste vice talmannen icke, att man skall komma med en detaljerad plan, utan endast med en plan i stora drag. Ja, men det har utskottet självt be-

gärt. Utskottet har till ett följande år anhållit om en generalplan i stora drag, och längre än till en sådan kan man nu inte komma. Alltså tycks inte reservanternas uppfattning på denna punkt skilja sig ifrån utskottets, för såvitt man inte på reservanternas sida sagt ett och 1 själva verket menat något annat.

Jag skall inte ingå i någon detaljkritik beträffande det Cederströmska förslagets idé att lägga

köket överst i huvudbyggnaden. Jag vill endast påpeka, att det är någonting, som kan passa, om man verkligen samlar alla kliniker i en byggnad, men icke, om man skall räkna med att ha vissa kliniker liggande utanför. Då mister detta förslag helt sin praktiska ändamålsenlighet.

Att det Cederströmska förslaget skulle vara billigare än det av kommissionen uppgjorda, är ett påstående, som man ingalunda har lyckats leda 1 bevis. Det talas om, att man därigenom skulle få kortare vägar mellan de olika klinikerna. Men det är å andra sidan uppvisat, att om man flyttar ögonoch öronklinikerna, såsom herr Cederström har föreslagit, får man tvärtom längre avstånd till behandlingslokalerna och till poliklinikerna.

Herr Westman var i sitt anförande särskilt rädd för att riksdagens prestige skulle lida, om den nu bifölle utskottets förslag, emedan riksdagen skulle visa lättsinne genom att bevilja vad han kallade »dessa oerhörda summor». Jag skall då till slut be att få något erinra om vad dessa summor innebära. Av de något över 21 miljoner, som den första etappen skulle kosta, komma mellan 11 och 12 miljoner på staten. Staten betalar alltså icke det hela, utan blott något mer än hälften. Jag vill vidare påminna om, att i detta sjukhuskomplex skulle inordnas garnisonssjukhuset, som för närvarande ligger ute på Kungsholmen och har en tomt, som, om den försäljes, skulle inbringa 3 eller 4, kanske 5 miljoner kronor. Vi kunna ju räkna lågt och säga 3. Vidare har man räknat med att Konradsbergs psykiatriska klinik skall flyttas till Norrbacka. Om man räknar lågt, har Konradsbergs tomt ett värde av mellan 7 och 8 miljoner; man kan mycket väl anslå värdet betydligt högre. Jag nämner emellertid dessa låga värderingssummor för att påpeka, att redan genom de tomtförsäljningar, som skulle kunna ske efter förflyttningen av dessa kliniker, får i själva verket staten tillbaka så gott som hela den summa, som den första etappen skulle kosta. Kostnaden för själva byggandet av den psykiatriska kliniken beräknar man icke till mer än en miljon kronor. Man finner alltså, att om vi räkna på detta sätt, så finansierar denna första etapp på sätt och vis sig själv. Och även om man ej för första etappen tager vinsten på Konradsbergstomten med i räkningen, så har man dock icke skäl att rygga tillbaka för kostnaderna. Dessa kostnader äro icke för stora, mina herrar, då det gäller ett så viktigt ändamål som att skaffa våra läkare en tidsenlig utbildning, en sak, som är så mycket mer behjärtansvärd, när vi tänka på de verkligt svåra förhållanden, under vilka läkarutbildningen skett i många år här i Stockholm på de olika kommunala sjukhusen, som av staden välvilligt upplåtits, men där man inte har särskilda undervisningslokaler eller andra anordningar, som äro avpassade för undervisningens behov.

När man talar om att landsorten inte har något intresse av detta, måste jag anse, att det är ett mycket kortsynt betraktelsesätt. Landsorten behöver väl och grundligt utbildade läkare, och det är detta, vi vilja tillgodose med detta undervisningssjukhus, som ju dessutom tillgodoser en del av vår sjukvård. Jag vill erinra om, att här i Stockholm har sjukvården under många år försvårats genom den oerhörda platsbristen vid sjukhusen, och läkarna måste vid vissa av dessa sjukhus bevittna, huru svårt sjuka patienter ligga och dö i korridorerna under förhållanden, som sannerligen inte kunna anses försvarliga 1 ett kultursamhälle.

Jag vill, herr talman, på det varmaste anbefalla kammaren att inte längre uppskjuta avgörandet av denna fråga på grund av projekt, vilka icke kunnat

uppvisas ha ett värde, som överstiger det nu föreliggande förslagets, och jag ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

I herr Paulis yttrande instämde herr Walles.

4. Sam Stadener (Liberala samlingspartiet, man)

Herr talman! För någon vecka sedan hade vi anledning att i denna kammare syssla med ett ärende, där även sjukhusfrågor berördes. Det gällde gymnastiska centralinstitutet och dess framtida organisation och arbetssätt. Detta ärende hade under ungefärligen 20 år varit föremål för utredningar. Kammaren liksom allmänheten för övrigt hade bör- Jat finna orimligt att tillbringa tvenne decennier med utredningar och att det måste vara oekonomiskt för statsverket att ägna så lång tid åt utredningar 1 en enda fråga. I de skrifter, som ligga till grund för Kungl. Maj:ts proposition om karolinska sjukhusets nybyggnad, uppgives, att utredningen omfattar jämnt hälften av nyssnämnda antalet år — den är nämligen 10 år gammal.

Det är inte utan att jag har det intrycket, att denna riksdag utgör ett slags vattentröskel för den utredningsflod, som redan börjat stiga betänkligt beträffande karolinska sjukhuset. Om riksdagen — och det beror nu på denna kammare — skulle fatta ett sådant beslut, att denna utredningsflod ytterligare stiger, tror jag, att man om utredningen om karolinska sjukhuset kommer att uttala samma omdöme som om den 20-åriga utredningen beträffande gymnastiska centralinstitutet. Om staten nedlägger så stora kostnader och ödslar med så mycken dyrbar tid på utredningar, måste man draga klokheten i dess handlande i tvivelsmål.

Det synes mig huvudsakligen vara tre anmärkningar, som blivit gjorda mot den framlagda propositionen och mot utskottets utlåtande. Jag försöker att utsöndra dem ifrån det nät av omgivande större och mindre anmärkningar, som utgöra den miljö, i vilken dessa tre stora huvudanmärkningar framträda. De äro följande: för det första saknaden av s. k. generalplan, för det andra en bristande koncentration av klinikerna inbördes och för det tredje en alltför ringa hänsyn till vissa medlemmar av sköterskepersonalen, de s. k. avdelningssköterskorna.

Innan jag nu säger något om dessa tre ting, vill jag anmärka, att det dessutom finns en annan ståndpunkt. De tre stora huvudgrupperna av anmärkningar, som jag nu citerat, ha icke utmynnat i avslagsyrkande, utan i ett yrkande om fortsatt utredning. Men det föreligger verkligen ett avslagsyrkande på det hela, och även om det inte kan vara anledning att sysselsätta sig alltför länge med detta yrkande, vill jag dock av vederbörlig hänsyn säga några ord om detsamma. Jag går då förbi vissa mera lösa och skrämmande rykten, som synas ligga till grund för avslagsyrkandet, exempelvis talet om »ett 50-tal byggnader», »ett 50-tal miljoner» o. s. v., alltsammans utkastade påståenden, för vilka intet bevis presterats. Att det har förekommit sådana rykten på vissa håll bevisar ju ingenting: instämmanden i ett obevisat

rykte utgöra intet bevis. Om jag går förbi detta, synes mig det viktigaste motivet för avslagsyrkandet vara, att för läkarutbildningen skulle norrbackabygget vara obehövligt.

Man återgår väl då, förmodar jag, till samma ståndpunkt, som var representerad av den förste ärade talaren i kväll, herr Westman, vid föregående ärs riksdag, då han tillsammans med en medmotionär gjorde sig till talesman för ett slags decentralisationsprincip beträffande den medicinska undervisningen och på allvar hemställde, huruvida icke den medicinska undervisningen kunde försiggå så, att lärare och lärjungar ambulerade omkring till de olika sjukhusen i Stockholms stad. Genom studier på det ena sjukhuset

efter det andra tänktes de studerande skola erhålla den nödvändiga läkarutbildningen. Jag förmodar, att det avslagsyrkande, som i dag gjorts på propositionen och utskottets utlåtande, utgår just från samma uppfattning, och då skulle naturligtvis all nybyggnad på Norrbacka eller annorstädes kunna anses vara obehövlig.

Men riksdagen har ju år 1930 tagit ståndpurkt till denna fråga, och riksdagen har bestämt avvisat denna uppfattning efter att ha tydligt och klart insett, hur orimlig en sådan anordning av den medicinska undervisningen skulle vara. Det förvånar mig i någon mån, att den, som framställde avslagsyrkandet för en stund sedan här i kammaren, strax efteråt uttalade, att när de byggnader bli färdiga, om vilka vi nu egentligen diskutera, d. v. s. den första etappens byggnader på Norrbacka, vilka, om allt går väl, beräknas vara färdiga om åtta år, äro de säkerligen redan omoderna. Han finner sålunda i det ena ögonblicket, att utvecklingen går så pass sakta, att man överhuvud taget icke behöver göra några ansträngningar alls för nybyggnad, men 1 nästa ögonblick finner han, att utvecklingen går så fort, att om man bygger aldrig så hastigt, räcker det ändå inte till.

Jag skall nu försöka att samla min framställning omkring de tre huvudsakliga anmärkningarna från dem, som anslutit sig till reservationen. Den första var, att här saknas s. k. generalplan. Ja, mina herrar, vad menar man med detta mystiska ord generalplan? Menar man, såsom jag gör, en generell plan, en översiktlig framställning, en totalvy, som omfattar hela företaget, alltså även de mera avlägsna delarna av detta byggnadsföretag, jämte naturligtvis en detaljerad uppställning med kostnadsberäkningar över de närliggande delarna, då finner jag, att anmärkningarna ha varit obefogade, ty en sådan generalplan föreligger. Menar man med generalplan återigen, att alla företagets byggnader, även de, vilkas uppförande ligger tilläventyrs 30 år fram 1 tiden, skola nu föreligga i detaljritningens form samt försedda med detaljerade beräkningar och kostnadsförslag, då begär man det orimliga. Detta har påpekats förut, och jag skall inte uppehålla mig därvid utan endast tillfoga att naturligtvis kunde kommissionen och Kungl. Maj:t ha fantiserat ihop siffror och kostnadsberäkningar angående vad som sannolikt kan inträffa om 30 år. Man kunde, säger jag, hava tecknat en tänkt bild av världen och Norrbacka om 30 år. Men vilket värde ha sådana fantasier, vilken betydelse kan man tillmäta dem som grundval för beslut och handlande? Man bör, tycker jag, i stället vara tacksam mot kommissionen för att den ärligt avvisat sådana fantasiskapelser och hållit sig till

verkligheten, till den gripbara verkligheten, som är inom räckhåll, d. v. s. den första etappen, och för det återstående nöjt sig med vad som är rimligt och korrekt: en generell plan i stora drag.

Den andra anmärkningen gick ut på att koncentreringen av klinikerna, de olika verkstäderna för läkarverksamheten på karolinska sjukhuset, inte var tillräckligt eller riktigt genomförd. TI detta uttalande ha alla, som yttrat sig på reservationens sida, instämt. Detta påstående har redan blivit bemött på ett utmärkt sätt av föregående talare, och jag skall icke upprepa vad som yttrats. På mig verkade såsom oemotsägligt vad han exempelvis anförde om orimligheten av att förlägga sinnessjukkliniken under samma tak som kliniken för sjuka, som behöva lugn och stillhet. Det synes mig också orätt att förlägga den pediatriska kliniken, barnkliniken — där naturligtvis mer eller mindre smittosamma barnsjukdomar ideligen förekomma — till samma komplex, där de övriga klinikerna äro samlade. En klinik, som inte blivit nämnd i detta sammanhang, är Gustaf V:s jubileumsklinik för cancersjuka, men det torde vara tämligen klart, att även den bör placeras på något isolerat ställe. Även av andra orsaker nödgas man emellertid vara försiktig med samman fö-

randet av klinikerna i alltför stort antal, bl. a. på grund av just den omständig- Ang. heten, som av den siste talaren blivit framhållen, nämligen att man inte kan uppförande av bygga byggnaderna hur mycket i höjden som helst. sjukhuset.

Men hela denna sak hur kliniker och polikliniker skola placeras i förhållan- (Forts.)

de till varandra, till inbördes stöd och samarbete, är dock, mina herrar, en rent medicinsk fackfråga. Jag tror, att vi såsom icke fackmän endast på ett försiktigt sätt kunna yttra oss därom. Själva avgörandet i detta spörsmål få vi nog träffa med ledning av auktoritetstro. Det lär inte kunna bli annorlunda. Det torde därför vara skäl att erinra sig, att saken varit föremål för behandling, om jag inte misstager mig, flera gånger inom lärarkollegiet vid karolinska institutet, och Kungl. Maj:ts förslag, som utskottet ansluter sig till, har en alldeles bestämd pluralitet av läkare på sin sida. Medicinalstyrelsen yttrar till och med i sitt utlåtande över 1930 års förslag, som vi nu debattera, att sammanförandet av klinikerna och reduktionen av utrymmena drivits längre i detta omarbetade förslag, än medicinalstyrelsen själv hade tänkt sig vara möjligt. Medicinalstyrelsen yttrar att byggnadsplanerna utmärka sig för stark koncentration och samtidigt för stor klarhet och överskådlighet. Den tredje av de stora anmärkningarna gällde **sjuksköterskorna**[3], särskilt avdelningssköterskorna. Jag har lyssnat med stor uppmärksamhet och med livligt intresse till de varmhjärtade ord, som herr förste vice talmannen i denna sak yttrat. Hans av mig vid så många tillfällen konstaterade människokärlek har givit sig tillkänna även i detta sammanhang. Herr förste vice talmannen behagade för en tid sedan i en debatt säga, att mitt hjärta i en viss angelägenhet klappade för fort, och att stark hjärtklappning är ett allvarligt symptom. Nu undrar jag, om inte detsamma inträffat med herr förste vice talmannens hjärtmuskel. Kanske är den i afton stadd i alltför hastig verksamhet. Förhållandet är, att sköterskeperscnalen i gemen enligt det framlagda

förslaget inte kommer att bo i sjukhuskomplexet. **Sjuksköterskorna³** i allmänhet skola bo i särskilt bostadshus utanför sjukhuskomplexet. Detta arrangemang har vidtagits av ekonomiska hänsyn, men också med tanke på deras personliga trevnad. Undantag göres för **s köterskor³**, som äro anställda vid operationsavdelning och vid förlossningsavdelning, men om dessa smärre grupper tala vi inte nu. De enda, som skulle bo i sjukhuskomplexet, äro föreståndarinnorna eller avdelningssköterskorna, detta naturligtvis med tanke på att de skola vara till hands, om de behövas. Det är på den punkten, herr vice talmannen infaller med sin sakliga kritik och säger: »Om de skola vara till hands, då de kunna behövas, så gäller detta dag och natt, och även under fritid, och alltså måste de sitta på sitt rum även, när de ha sin fritid, därför att de kanske inte eljest äro till hands, då de behövas.» I denna anmärkning har herr förste talmannen alldeles rätt, men det faller av sig självt, att om avdelningssköterskan har sin bostad i närheten av avdelningen, är **hon²** oftare till hands, än om **hon²** har sin bostad utanför komplexet i ett särskilt bostadhus. **Hon²** har ju sin fritid och kan naturligtvis använda fritiden efter behag, och det kan därför inträffa, att **hon²** är borta under ett ögonblick, då **hon ²** behövs, och då får man reda sig på annat sätt. I flertalet fall är **hon²** emellertid till hands lättare och oftare, om **hon²** bor på avdelningen än om **hon²** bor i ett bostadshus. Herr förste vice talmannens anmärkning, vars riktighet och logiska innebörd jag inte vill bestrida, är realiter inte så vägande som den synes vara.

Mera vägande är det däremot, då herr förste vice talmannen säger, att dessa avdelningssköterskor behöva rekreation i fullaste mening och att deras nervspännande arbete bör tillförsäkra dem sådan absolut frihet att de kunna vara sig själva på sin fritid, och att därför är förslaget i vad det avser dessa **sköterskor³** frihetsfientligt och kränkande för individens rättighet att vara sig själv. Jag skall för att svara på denna mycket vägande och bestickande an-

märkning framställa ett par frågor: hur kommer det sig, att sjuksköterskekåren är så lätt att rekrytera i vårt land? Har det försports någon svårighet att rekrytera sjuksköterskekåren? Jag tillfogar ännu en fråga: ge **sjuksköterskorna³** i vårt land intryck av att vara dystra och nedstämda till humöret? För mig, som under en ganska lång levnad haft täta anledningar och stundom dagliga anledningar att sammanträffa med **sjuksköterskor³** i och utanför deras gärning, står det fast först och främst, att rekryteringen erbjuder inga svårigheter, och för det andra, att **sjuksköterskorna³** i regel utmärka sig för ett jämnt och soligt lynne. Patienternas varma tacksamhet för de tjänster, som **sjuksköterskan³** gör dem, hänför sig i mångt och mycket till denna soliga, upplyftande och glada sinnesstämning, som i allmänhet utmärker **he nne²**. Nu kanske det invändes, att detta gäller **sjuksköterskor³**, som inte bo inom sina avdelningar. Jag vill då utan att gå närmare i detalj säga, att jag känner till, att det råder skillnad mellan bostadsförhållandena vid sjukhusen på olika platser, men jag har kunnat iakttaga såväl **sjuksköterskor³**, som bott i själva sjukhuskomplezxet, som **sköterskor³**, vilka bott ute i samhället eller i särskilt bostadshus intill sjukhuset.

En annan omständighet kan det vara skäl att påpeka härvidlag. Det framhålles i den

promemoria, som herr Israel Holmgren bifogat sin motion. Det uppges där, att de flesta **sjuksköterskor³** inte önska att flytta ut i bostadshus, utan vilja helst bo på sina sjukavdelningar. Författaren säger: »Jag tvivlar inte på detta.» Men han menar, att de skola tvingas till ändring. Antingen de vilja eller inte, menar han, att de skola flytta på annat håll. Mina herrar, jag förstår nog, att barn och andra personer, som inte begripa sitt eget bästa, måste man tvinga. Men jag tror inte att man kan tvinga människor att känna sig glada, tillfredsställda och lyckliga. Om avdelningssköterskorna, vilket av författaren intygas, verkligen känna sig oroliga för sina sjuka, därest de inte få vara i deras närhet, på tider, då de äro hemma, blir **sköterskans³** glädje av att bo i ett särskilt bostadhus en tvångsvis framkallad glädje, vilket är en psykologisk orimlighet.

Av vad jag nu sagt följer inte alls, att man bör inplacera **sköterskorna³** överlag i sjukhuskomplexen. Men av vad jag anfört följer, att i denna fråga böra vi vara lyhörda, så att vi höra oss för hos dem det närmast gäller. Två parter äro att avlyssna. Den ena parten är **sjuksköterskan³**, och **hennes²** mening har blivit framförd. Den andra parten är patienten: jag är ganska säker på, att vi skulle från detta håll få höra ett livligt instämmande i nödvändigheten av och tacksamheten över att de ansvarskännande och i sjukhusutbildning högtstående avdelningssköterskorna inte bo alltför långt från patienternas sjukläger.

Jag har härmed talat om de tre stora huvudanmärkningar, som under debatten framställts mot det föreliggande förslaget. Reservationen slutar med ett yrkande, som säger sig icke önska uppskov. Det har också här från reservanternas sida uttryckligen betonats, att ett bifall till reservationen inte skulle innebära uppskov med företaget. Man föreslår att bevilja den begärda summan på 750,000 kronor, men tillfogar, att denna summa inte får användas till något annat än till vissa särskilt uppgivna arbeten: nedläggande av huvudrör, företagande av dräneringar, framdragande av vattenoch avloppsledningar samt vägar i och utanför tomten, planering etc., saker, som man tror kunna nu strax utföras, vare sig den ena eller den andra planen för byggnadernas uppförande skulle följas längre fram. Vidare föreslå reservanterna, att vid sidan om den kommitté, som kallas byggnadskommittén och som skall handha dessa 750,000 kronor, skall tillsättas en ny utredningskommitté, som skall lägga fram, som det heter, ett alternativt byggnadsförslag vid sidan om det redan föreliggande. Och inte nog med detta, utan byggnadskommittén plus den nya utredningskommittén skall samarbeta med statens

organisationsnämnd. Vi få ett klöverblad av tre arbetande kommittéer, som, efter vad reservanterna föreställa sig, i paradisisk endräkt komma att utföra sitt uppdrag och lägga fram sitt betänkande inom ett år. Reservanterna uttala detta försiktigtvis på ett mycket modest sätt: »Ifrågavarande utredning lär böra så anordnas, att den kan slutföras under en tid av ett år.» Det är, som herrarna höra, en hopning av modesta verb. Jag yttrade mig härom litet närmare för några dagar sedan i andra kammaren. Låt oss tänka oss, att vi satte i gång med detta nya utredningsföretag så snart som möjligt. Antag allra först, att vi verkligen funne personer, som vore villiga till detta nya utredningsuppdrag och som åtnjöte förtroende från

den medicinska sakkunskapens sida — det är ju uppenbart, att man inte kan välja andra. Antag alltså, att vi verkligen lyckades finna dem, vilket kanske inte är så alldeles lätt, och att de började arbeta, så snart riksdagen slutat, låt oss säga den 1 juli i år. Då behöva de givetvis, i synnerhet med den tredelade arbetsapparat, som jag nyss beskrivit, minst ett år på sig. Då äro vi framme vid den 1 juli 1932. Sedan skall ärendet på remiss till karolinska institutet, medicinalstyrelsen och andra medicinska auktoriteter, till statskontoret och till äventyrs även på annat håll. Vi kunna rimligtvis inte beräkna att få in ärendet i utrett skick förrän om ytterligare ett år, d. v. s. 1933. Proposition skulle i lyckligaste fall kunna avlämnas till riksdagen 1934, och — om riksdagen då fattar definitivt beslut i saken, vilket ingen vet — skulle det första spadtaget alltså icke tagas förrän den 1 juli samma år. Detta är enligt min tanke att verkligt försena saken. Man må kalla det uppskov eller icke uppskov, men för mig ser det ut som ett verkligt uppskov med ärendet. Riksdagen yttrade dock 1930 följande —— jag citerar ordagrant: »Riksdagen finner de skäl, som anförts för ett omedelbart avgörande av karolinska institutets byggnadsfråga, så starka, att riksdagen anser ett vidare undanskjutande av dessa frågor icke vara försvarligt.> Men ändå föreslå reservanterna nu med en något väl starkt accentuerad envishet, trots detta riksdagsbeslut, antagandet av ett förslag, som innebär ett verkligt uppskov på minst tre eller fyra år.

Reservanterna föreslå, att man under tiden begagnar de 750,000 kronor, som nu skulle beviljas, till de av mig omnämnda arbetena. Förslaget faller på sin egen orimlighet. Man kan kanske utanför tomten företaga vissa arbeten — även det torde vara osäkert — men inne på tomten lär man inte kunna göra det, förrän man vet, hur byggnaderna skola se ut och var de skola vara belägna. Detta lär alldeles särskilt bliva fallet, om herr Holmgrens tankegång skulle vinna beaktande. Han yttrade nämligen, att när han instämde med reservanterna 1 önskan om en alternativ utredning, åsyftade han en grundlig omarbetning. Han sade t. o. m. en principomarbetning, d. v. s. man skulle börja från början igen. Han kände sig viss om att det var bättre att vänta ett och annat år, och var sålunda inställd på uppskov för att sedan få det allra bästa. Men hur veta vi, att vi sedan få det allra bästa? Vem kan någonsin garantera oss det? Reservationen, sådan herr Holmgren tänker sig den, går ut på en reformering till huvud och lemmar, d. v. s. en alldeles ny uppläggning av alltsammans. Säkerligen måste detta medföra årslånga uppskov, innan riksdagen får det nya uppslaget i sina händer.

Jag är rädd, att jag tagit kammarens tid alltför mycket i anspråk. Jag skulle gärna ha velat yttra mig något närmare om de ekonomiska frågorna, som äro förknippade med ärendet, men det är ju möjligt, att de under den följande debatten bliva behandlade.